

Fundamentos normativos y gestión del escenario en primeros auxilios

Breve descripción:

Este componente formativo desarrolla los fundamentos normativos, legales y técnicos que regulan la actuación del primer respondiente, así como la gestión segura del escenario de emergencia. Incluye bioseguridad, triage, cadena de custodia, activación del sistema de emergencias y aseguramiento de la escena, conforme a lineamientos vigentes.

Marzo 2026

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Fundamentos de los primeros auxilios	7
1.1. Generalidades de los primeros auxilios	7
1.2. Rol y límites del primer respondiente	10
1.3. Evaluación inicial del lesionado	12
1.4. Bioética y comunicación	17
2. Marco normativo y responsabilidades	20
2.1. Normatividad vigente	20
2.2. Responsabilidades y Código Penal	22
2.3. Legislación en emergencias y rol de la Cruz Roja	24
3. Sistema de emergencias	28
3.1. Sistema de Emergencias Médicas (SEM)	28
3.2. Red pública de urgencias y número único	30
3.3. Activación y técnica de llamada	31
4. Gestión del riesgo	34
4.1. Urgencia, emergencia y factores de riesgo	35
4.2. Identificación de riesgos y tipos de accidentes	36
4.3. Medidas de minimización y precaución	39

5.	Aseguramiento y control del escenario	42
5.1.	Principios y criterios de aseguramiento	43
5.2.	Acordonamiento y control del evento.....	44
6.	Clasificación y custodia	47
6.1.	Triage y aplicación básica	47
6.2.	Cadena de custodia.....	53
7.	Bioseguridad y preparación	56
7.1.	Principios y técnica aséptica	57
7.2.	Métodos de barrera	60
7.3.	Botiquín de primeros auxilios y preparación de insumos	61
	Síntesis	64
	Glosario.....	66
	Referencias bibliográficas	69
	Créditos.....	71

Introducción

La atención inicial en situaciones de urgencia y emergencia constituye una acción prioritaria en la protección de la vida y la integridad de las personas. Los primeros auxilios representan la primera respuesta organizada frente a eventos que comprometen la salud o la seguridad, y su adecuada aplicación puede reducir complicaciones, minimizar riesgos y contribuir a la estabilización inicial de la víctima mientras se activa el sistema de atención en salud.

En Colombia, la actuación del primer respondiente se encuentra enmarcada dentro de lineamientos normativos y responsabilidades legales que regulan su intervención. Esto implica actuar conforme a principios éticos, bioéticos y de seguridad, respetando el alcance y los límites de su rol, evitando conductas que puedan generar daño adicional y garantizando el cumplimiento de deberes como la activación oportuna del sistema de emergencias y la solicitud adecuada de ayuda.

En este contexto, el presente componente formativo tiene como propósito proporcionar los fundamentos conceptuales, normativos y técnicos necesarios para que el aprendiz comprenda el rol del primer respondiente y gestione de manera segura y organizada el escenario de emergencia. Este conocimiento constituye la base para el desarrollo de las acciones prácticas de atención que serán abordadas en los componentes posteriores del programa de formación.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Fundamentos normativos y gestión del escenario en primeros auxilios



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video: Fundamentos normativos y gestión del escenario en primeros auxilios

En 1859, tras la batalla de Solferino, un ciudadano suizo evidenció que cientos de heridos quedaban abandonados sin atención. Ese acontecimiento motivó a Henry Dunant a promover una iniciativa humanitaria que más tarde daría origen al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Con el tiempo, esa necesidad de asistir de manera inmediata y organizada evolucionó hacia lo que hoy se conoce como primeros auxilios.

Los primeros auxilios dejaron de ser actos improvisados de ayuda para convertirse en una práctica fundamentada en conocimientos básicos, responsabilidad ética y criterios de seguridad. En la actualidad, la actuación del primer respondiente exige algo más que buena voluntad; requiere comprender el entorno, identificar riesgos y proteger la vida sin generar nuevos peligros.

La intervención adecuada implica reconocer el marco normativo vigente, los límites legales de actuación y las responsabilidades derivadas de la legislación colombiana. Asimismo, supone conocer el funcionamiento del Sistema de Emergencias Médicas, aplicar principios de gestión del riesgo, asegurar el escenario y priorizar la atención cuando existan múltiples víctimas mediante criterios básicos de triage.

De igual manera, se deben aplicar medidas de bioseguridad, métodos de barrera y principios básicos de preservación del escenario cuando existan posibles implicaciones legales.

Actuar sin conocimiento puede agravar una situación crítica. Actuar con formación, prudencia y criterio técnico permite preservar la vida, proteger la integridad de las personas y contribuir a una respuesta organizada y segura ante la emergencia.

1. Fundamentos de los primeros auxilios

La atención en primeros auxilios constituye la primera respuesta organizada frente a una situación de urgencia o emergencia, y forma parte del deber general de solidaridad consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. Su finalidad es preservar la vida, prevenir complicaciones, limitar el daño y facilitar el acceso oportuno al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Desde el punto de vista técnico, los primeros auxilios se fundamentan en protocolos estandarizados internacionalmente (Cruz Roja Colombiana, Guías AHA para Soporte Vital Básico) y en el marco normativo nacional que regula la responsabilidad del ciudadano frente a situaciones de peligro (Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000).

La intervención debe ser:

- Oportuna.
- Proporcional al riesgo.
- Segura para el auxiliador.
- Limitada a la competencia del primer respondiente.

1.1. Generalidades de los primeros auxilios

Los primeros auxilios constituyen el conjunto de acciones inmediatas y temporales que se brindan a una persona ante una situación de urgencia o emergencia, con el propósito de preservar la vida, evitar el agravamiento de las lesiones y facilitar el acceso oportuno a la atención médica especializada. Representan la primera respuesta

organizada frente a un evento adverso y forman parte esencial de la cadena de atención en salud.

Es importante comprender que los primeros auxilios:

- No reemplazan la atención médica profesional.
- No constituyen tratamiento definitivo.
- No implican actos médicos especializados.
- Son medidas transitorias hasta la llegada del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los primeros auxilios se caracterizan por ser:

- **Inmediatos:** se aplican en el mismo lugar donde ocurre el evento.
- **Temporales:** mantienen estabilidad básica hasta recibir atención avanzada.
- **Básicos:** se limitan a técnicas elementales y no invasivas.
- **Proporcionales:** la intervención debe corresponder a la gravedad observada.
- **Seguros:** no deben generar riesgos adicionales.

Estas características garantizan que la actuación sea útil, organizada y ajustada a protocolos técnicos reconocidos, como los establecidos por la Cruz Roja Colombiana y las Guías de Soporte Vital Básico de la American Heart Association (AHA).

La finalidad principal se orienta a cuatro objetivos esenciales:

- Conservar la vida.
- Prevenir complicaciones secundarias.

- Reducir el dolor y la ansiedad.
- Promover recuperación inicial mientras llega ayuda especializada.

En eventos críticos, la actuación temprana puede disminuir significativamente la mortalidad y las secuelas, especialmente en casos de paro cardiorrespiratorio, hemorragias severas o trauma.

Los primeros auxilios forman parte del primer eslabón de la cadena de supervivencia, que comprende:

- Reconocimiento temprano del evento.
- Activación inmediata del sistema de emergencias.
- Aplicación de soporte vital básico.
- Atención avanzada.
- Cuidados posteriores.

El éxito de esta cadena depende de la rapidez y coordinación entre la respuesta comunitaria y el sistema formal de salud.

Comprender la naturaleza y finalidad de los primeros auxilios permite establecer el marco general de actuación frente a una emergencia. Sin embargo, para garantizar que esta intervención sea segura, legal y técnicamente adecuada, es necesario definir con claridad quién interviene, cuál es su función y cuáles son los límites de su actuación. En este contexto, el rol del primer respondiente adquiere especial relevancia dentro de la respuesta inicial ante situaciones de urgencia o emergencia.

1.2. Rol y límites del primer respondiente

El primer respondiente es la persona que interviene inicialmente en el lugar del evento antes de la llegada de los servicios especializados de salud o de organismos de socorro. Puede tratarse de un ciudadano capacitado, personal institucional no sanitario o integrante de brigadas de emergencia.

Su actuación se fundamenta en el principio constitucional de solidaridad (Artículo 95 de la Constitución Política de Colombia), el cual establece el deber de obrar frente a situaciones que pongan en peligro la vida o la integridad de otras personas.

La función del primer respondiente no es realizar actos médicos, sino brindar asistencia básica y organizar la respuesta inicial. Su intervención se orienta a:

- Identificar riesgos inmediatos.
- Garantizar condiciones mínimas de seguridad.
- Evaluar de forma básica el estado del lesionado.
- Activar oportunamente el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
- Aplicar técnicas básicas no invasivas.
- Proporcionar información clara a los servicios especializados.

Su actuación debe ser inmediata, prudente y ajustada a protocolos técnicos reconocidos.

El alcance del primer respondiente está determinado por:

- Su nivel de formación.
- Las condiciones del entorno.

- La gravedad de la situación.
- Los recursos disponibles.

Puede realizar acciones como:

- Control de hemorragias externas.
- Maniobras básicas de soporte vital.
- Inmovilización básica.
- Protección de la escena.
- Acompañamiento y contención emocional inicial.

Estas intervenciones buscan mantener estabilidad hasta la llegada del personal sanitario.

El primer respondiente debe actuar dentro de límites claramente definidos para evitar daño adicional o implicaciones legales. No debe:

- Realizar procedimientos invasivos sin formación médica.
- Administrar medicamentos sin indicación profesional.
- Manipular innecesariamente a la víctima.
- Emitir diagnósticos clínicos.
- Sustituir la atención médica especializada.

El exceso en la intervención puede configurar conductas imprudentes o culposas, de acuerdo con el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), especialmente cuando se actúa con negligencia o impericia.

1.3. Evaluación inicial del lesionado

Una vez identificado el rol y los límites de actuación del primer respondiente, la intervención debe centrarse en la valoración inicial del lesionado. Esta fase constituye el primer momento operativo de contacto directo con la víctima y tiene como finalidad identificar condiciones que comprometan la vida de manera inmediata.

La evaluación inicial debe ser rápida, estructurada y orientada a la priorización. No busca realizar diagnósticos médicos, sino reconocer signos evidentes que indiquen riesgo vital y permitan activar oportunamente el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

a) Seguridad del entorno

Esta actividad se realiza antes del contacto. Antes de aproximarse a la víctima, el primer respondiente debe:

- Evaluar riesgos activos (tránsito vehicular, fuego, electricidad, estructuras inestables y sustancias peligrosas).
- Verificar que cuenta con elementos básicos de protección (guantes y mascarilla si es necesario).
- Confirmar que puede intervenir sin poner en riesgo su vida o la de terceros.

La seguridad personal es prioritaria y se fundamenta en el principio de no maleficencia, que implica no generar nuevos daños ni exponerse a riesgos innecesarios. Si el escenario representa peligro elevado, la prioridad es activar organismos especializados y no intervenir directamente. Los principios de no maleficencia y

beneficencia se desarrollan ampliamente en la literatura bioética (Beauchamp & Childress, 2019).

b) Aplicación del principio PAS

Constituye una secuencia operativa básica que orienta la actuación del primer respondiente en el lugar del evento. Esta metodología permite priorizar la seguridad, activar oportunamente el sistema de emergencias y brindar asistencia inicial organizada. A continuación, se presenta de manera esquemática esta secuencia de intervención:

- **Proteger**
 - Asegurar la escena.
 - Evitar nuevos incidentes.
 - Señalizar o acordonar cuando sea necesario.
- **Avisar**
 - Activar el Sistema de Emergencias Médicas (123 u otro número territorial).
 - Informar ubicación exacta, número de víctimas y condición aparente.
- **Socorrer**
 - Brindar asistencia básica dentro del alcance del primer respondiente.

Este principio evita actuaciones impulsivas y establece un orden lógico de intervención.

c) Evaluación primaria estructurada (valoración ABC básica)

Una vez asegurada la escena, se realiza una valoración rápida orientada a identificar amenazas vitales. A continuación, se describe la estructura ABC:

- **Estado de conciencia y vía aérea**
 - Verificar si la víctima responde al llamado verbal.
 - Si no responde, estimular suavemente.
 - Confirmar que la vía aérea esté libre de obstrucción visible.
 - No introducir dedos en la boca si no se observa un objeto claramente removible.
 - La ausencia de respuesta es un signo de gravedad.
- **Respiración**
 - Observar movimientos torácicos.
 - Escuchar y sentir la respiración durante máximo 10 segundos.
 - Identificar respiración ausente, irregular o dificultosa.
 - Si la víctima no respira o presenta respiración anormal, se debe activar inmediatamente el SEM (si no se ha hecho) e iniciar maniobras básicas según formación (por ejemplo, RCP si está capacitado).
- **Circulación y hemorragias visibles**
 - Identificar sangrado abundante.
 - Evaluar coloración de piel (palidez extrema o cianosis).
 - Verificar signos evidentes de shock (sudoración fría o debilidad marcada).

- Si hay hemorragia externa, aplicar presión directa con material limpio, no retirar objetos incrustados y no aplicar torniquetes improvisados sin formación específica.

d) Identificación de signos evidentes de trauma

Este proceso se realiza posterior a la valoración ABC básica. Es de vital importancia observar:

- Deformidades visibles.
- Heridas abiertas.
- Quemaduras.
- Posible lesión cervical o de columna.
- Dolor intenso localizado.
- En casos de trauma, no movilizar innecesariamente, no levantar a la víctima si no existe peligro inminente y evitar movimientos bruscos.

e) Conducta según estado de conciencia

La intervención se ajusta al estado de conciencia de la víctima, orientando las acciones iniciales hacia la valoración primaria y la aplicación de medidas inmediatas de soporte. A continuación, se presentan las acciones específicas que deben implementarse según se trate de una víctima consciente o inconsciente:

- **Víctima consciente**
 - Presentarse e identificar el rol.
 - Preguntar qué ocurrió.

- Indagar sobre dolor, mareo o dificultad respiratoria.
- Mantener comunicación calmada y tranquilizadora.

- **Víctima inconsciente**

- Verificar respuesta.
- Evaluar respiración.
- Activar sistema de emergencias.
- Colocar en posición lateral de seguridad si respira y no hay sospecha de trauma.

f) Lo que NO debe hacer el primer respondiente

- Administrar medicamentos.
- Manipular fracturas sin necesidad.
- Retirar objetos incrustados.
- Realizar procedimientos invasivos.
- Trasladar a la víctima sin condiciones adecuadas.

g) Activación obligatoria del Sistema de Emergencias (SEM) cuando exista

- Pérdida de conciencia.
- Dificultad respiratoria.
- Hemorragia abundante.
- Dolor torácico intenso.
- Trauma significativo.
- Sospecha de lesión cervical o craneoencefálica.

La activación oportuna forma parte del deber legal de auxilio establecido en la normatividad colombiana (Ley 599 de 2000, omisión de socorro). La evaluación inicial no reemplaza la valoración médica profesional, sino que constituye una fase temporal de estabilización básica hasta la llegada del personal especializado. Esta valoración permite identificar condiciones que comprometen la vida y orientar la intervención técnica del primer respondiente; sin embargo, su eficacia no depende únicamente de la correcta aplicación de los protocolos, sino también de una actuación ética y comunicativa que garantice una intervención respetuosa y humanizada.

1.4. Bioética y comunicación

La intervención en primeros auxilios no constituye únicamente un acto técnico; también representa un acto ético que implica respeto por la dignidad, la integridad y la autonomía de la persona afectada. La forma en que el primer respondiente actúa y se comunica influye directamente en la estabilidad emocional de la víctima y en la organización del entorno durante la emergencia.

La conducta bioética se fundamenta en principios universalmente reconocidos en el ámbito de la salud y compatibles con el ordenamiento jurídico colombiano, particularmente con el respeto por la dignidad humana consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política. Aunque el primer respondiente no realiza un acto médico formal, su actuación debe orientarse por los siguientes principios:

- **Respeto por la dignidad humana:** tratar a la persona con consideración y humanidad.
- **No maleficencia:** evitar generar daño adicional.

- **Beneficencia:** actuar buscando el mayor beneficio posible para la víctima.
- **Confidencialidad:** no divulgar información personal innecesaria.
- **Prudencia:** actuar dentro de los límites de su competencia.

Estos principios orientan la toma de decisiones en situaciones de presión y reducen la probabilidad de intervenciones imprudentes.

Cuando la víctima está consciente y orientada, se debe:

- Explicar brevemente lo que se va a hacer.
- Solicitar autorización para intervenir.
- Respetar la negativa, salvo que exista riesgo vital evidente.

En caso de inconsciencia, se presume consentimiento para acciones orientadas a preservar la vida, en concordancia con el principio de protección de la vida y la integridad.

La comunicación cumple un papel central en la estabilización del entorno. Una interacción adecuada permite:

- Reducir el pánico.
- Facilitar la colaboración de terceros.
- Generar confianza en la víctima.
- Mejorar la coordinación con organismos de socorro.

Durante la intervención se recomienda:

- Utilizar un tono calmado y firme.
- Dar instrucciones claras y breves.
- Evitar juicios o reproches.

- No generar falsas expectativas.
- Informar lo que se está haciendo.

El control emocional del auxiliador constituye un componente ético y operativo esencial. Mantener la calma reduce errores, mejora la toma de decisiones, transmite seguridad a la víctima y facilita la coordinación. En este sentido, la autorregulación emocional forma parte de la competencia integral del primer respondiente.

El análisis de los fundamentos técnicos, el rol del primer respondiente y los principios bioéticos que orientan su actuación permite comprender cómo intervenir frente a una emergencia desde una perspectiva operativa y humanizada. No obstante, esta actuación también se encuentra enmarcada en disposiciones legales que regulan el deber de ayuda, la responsabilidad individual y la articulación con el sistema de salud, por lo que resulta necesario examinar el marco normativo que sustenta la intervención en primeros auxilios y define sus implicaciones jurídicas.

2. Marco normativo y responsabilidades

La atención en primeros auxilios no se desarrolla en un vacío jurídico; por el contrario, se encuentra respaldada y delimitada por normas constitucionales, legales y reglamentarias que orientan el deber ciudadano de actuar frente a situaciones de peligro, así como los límites de dicha intervención.

El conocimiento del marco normativo permite al primer respondiente actuar con mayor seguridad jurídica, evitando tanto la omisión injustificada como la intervención imprudente.

2.1. Normatividad vigente

La Constitución Política de Colombia reconoce la vida como derecho fundamental (artículo 11) y establece la obligación del Estado de proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes (artículo 2). Este fundamento respalda la existencia de mecanismos institucionales para la atención de emergencias y el deber social de actuar solidariamente.

A continuación, se presentan las principales disposiciones relacionadas con la actuación en primeros auxilios:

Tabla 1. Marco normativo de los primeros auxilios en Colombia

Norma	Disposición relevante	Implicación para primeros auxilios
Constitución Política de Colombia.	Art. 1 (dignidad humana), Art. 2 (protección de la vida), Art. 49 (derecho a la salud) y Art. 95 (deber de solidaridad).	Fundamenta la obligación ética y social de auxiliar a quien lo necesita.
Ley 599 de 2000 – Código Penal.	Art. 131 (omisión de socorro) y disposiciones sobre conductas culposas.	Establece responsabilidad por no prestar ayuda cuando es posible hacerlo sin riesgo propio.
Ley 1523 de 2012.	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Define la organización institucional para la preparación y respuesta ante emergencias.
Normativa del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Atención inicial de urgencias.	Garantiza la prestación obligatoria de atención en casos de urgencia.

Estas disposiciones no obligan al ciudadano a realizar procedimientos especializados; sin embargo, sí establecen el deber de actuar cuando sea posible hacerlo sin poner en riesgo la propia seguridad.

Para profundizar en la normatividad y lineamientos técnicos aplicables a primeros auxilios y atención inicial en urgencias, se recomienda consultar:

- Cruz Roja Colombiana. Manual de Primeros Auxilios.
- Ley 1523 de 2012.
- Lineamientos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en Colombia.

2.2. Responsabilidades y Código Penal

La actuación del primer respondiente no solo tiene implicaciones técnicas y éticas, sino también jurídicas. En Colombia, el deber de actuar frente a una persona en peligro se fundamenta en el principio constitucional de solidaridad consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política, el cual establece la obligación de obrar conforme a la ley y responder ante situaciones que comprometan la vida o integridad de otros.

No obstante, esta responsabilidad no implica sustituir al personal médico ni asumir funciones para las cuales no se tiene formación. La intervención debe ser proporcional, prudente y ajustada a las capacidades reales del auxiliador.

El artículo 131 de la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano, establece el delito de omisión de socorro, que se configura cuando una persona no auxilia a otra que se encuentra en peligro grave y manifiesto, pudiendo hacerlo sin riesgo propio. De esta disposición se desprende que:

- Existe un deber razonable de prestar ayuda.
- La ayuda puede consistir en intervenir directamente o en solicitar asistencia.
- No se exige poner en peligro la propia vida.

En el contexto de los primeros auxilios, la activación oportuna del número único de emergencias 123 constituye una forma válida de cumplimiento del deber de socorro.

Además de la omisión, el Código Penal contempla responsabilidad por conductas culposas cuando el daño se produce por:

- Negligencia, entendida como falta del cuidado debido.
- Imprudencia, referida a una actuación temeraria.
- Impericia, asociada a la falta de conocimiento técnico.
- Violación de reglamentos, por incumplimiento de protocolos establecidos.

Por ello, el primer respondiente debe actuar únicamente dentro del ámbito de su formación y evitar intervenciones que excedan su competencia. Nadie está obligado a exponerse a peligro grave para prestar ayuda, pero sí debe hacerlo cuando sea razonablemente posible. El deber de solidaridad no convierte al ciudadano en profesional de la salud; en muchos casos, la activación del Sistema de Emergencias Médicas constituye el cumplimiento básico y suficiente de la obligación de asistencia.

Este equilibrio entre el deber de ayuda y el límite de competencia protege tanto a la víctima como al auxiliador y se concreta en el principio de debida diligencia, el cual implica:

- Actuar cuando exista posibilidad real de ayuda.
- No exceder las propias capacidades.
- No generar daño adicional.
- Coordinar con los servicios especializados.

La debida diligencia permite evitar tanto la omisión injustificada como la intervención imprudente. Si bien el Código Penal establece el deber individual de actuar frente a una persona en peligro, la respuesta ante emergencias no depende exclusivamente del ciudadano. Existe un marco normativo más amplio que organiza la gestión institucional del riesgo y define la coordinación entre autoridades, organismos de socorro y comunidad, lo que hace necesario analizar la legislación que regula la atención de emergencias y desastres en Colombia.

2.3. Legislación en emergencias y rol de la Cruz Roja

La respuesta ante emergencias en Colombia se encuentra regulada principalmente por la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Esta norma establece que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre el Estado, las entidades territoriales, el sector privado y la comunidad, incluyendo la participación activa de ciudadanos capacitados en primeros auxilios.

El SNGRD tiene como finalidad prevenir desastres, reducir el impacto de eventos adversos, organizar la respuesta ante emergencias y coordinar la recuperación posterior. Para ello, estructura la gestión del riesgo en tres procesos fundamentales:

Tabla 2. Procesos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Proceso	Descripción	Relación con el primer respondiente
Conocimiento del riesgo.	Identificación y análisis de amenazas y vulnerabilidades.	Permite reconocer situaciones potencialmente peligrosas.
Reducción del riesgo.	Implementación de medidas preventivas y correctivas.	Promueve la preparación comunitaria.
Manejo de desastres.	Respuesta y recuperación ante eventos adversos.	Ubica al primer respondiente en la fase de respuesta inmediata.

La actuación del primer respondiente se enmarca dentro del proceso de manejo de desastres, específicamente en la fase de respuesta inmediata, actuando como primer eslabón en la cadena organizada de atención.

La legislación en gestión del riesgo establece coordinación con diversas entidades operativas:

Tabla 3. Entidades de coordinación en la respuesta a emergencias

Entidad	Función general
Cuerpos de bomberos.	Atención de incendios, rescates y materiales peligrosos.
Defensa Civil.	Apoyo en búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.
Cruz Roja Colombiana.	Atención prehospitalaria, ayuda humanitaria y gestión comunitaria.
Sistema de Emergencias Médicas (SEM).	Atención prehospitalaria y traslado asistido.
Autoridades locales.	Coordinación territorial y activación de planes de emergencia.

El primer respondiente no sustituye a estas entidades, sino que actúa de manera complementaria hasta la llegada del personal especializado.

Comprender la legislación en gestión del riesgo permite reconocer la importancia de la coordinación institucional, entender el propio rol dentro de un sistema más amplio y actuar de manera organizada en eventos múltiples, facilitando la transición hacia la atención especializada.

El marco normativo analizado demuestra que la actuación del primer respondiente se encuentra respaldada por principios constitucionales, disposiciones penales y normas de gestión del riesgo que orientan tanto el deber de ayuda como los límites de intervención. En consecuencia, resulta necesario conocer el funcionamiento del Sistema de Emergencias Médicas y la red pública de urgencias en Colombia, así como los mecanismos adecuados para su activación.

3. Sistema de emergencias

El sistema de emergencias en Colombia constituye una red organizada de instituciones, recursos humanos, infraestructura y protocolos orientados a garantizar la atención oportuna de personas en situación crítica. Su finalidad es coordinar la respuesta desde el momento en que ocurre el evento hasta la estabilización del paciente en un centro asistencial, asegurando continuidad en la atención.

Este sistema integra el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la red pública y privada de urgencias, los organismos de socorro y las autoridades territoriales, bajo principios de oportunidad, articulación interinstitucional y protección de la vida. Su funcionamiento depende tanto de la capacidad operativa de las instituciones como de la activación adecuada por parte de la ciudadanía.

En este contexto, el primer respondiente desempeña un papel fundamental como primer eslabón en la cadena de atención. La identificación temprana de la emergencia, la valoración inicial y la activación oportuna del número único constituyen acciones determinantes para optimizar los tiempos de respuesta y reducir complicaciones.

A continuación, se describen los componentes del Sistema de Emergencias Médicas, la estructura de la red pública de atención y el procedimiento adecuado para la activación del servicio.

3.1. Sistema de Emergencias Médicas (SEM)

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) es el conjunto organizado de servicios, recursos humanos, infraestructura y procedimientos destinados a brindar atención

inmediata a personas que presentan una condición que compromete su vida, integridad o funcionalidad. Su propósito es garantizar una respuesta rápida, coordinada y técnicamente adecuada desde el lugar del evento hasta la remisión a un centro asistencial.

En Colombia, el SEM se articula con:

- Secretarías de Salud departamentales y municipales.
- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
- Servicios de ambulancia básicos y medicalizados.
- Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE).
- Organismos de socorro.

El CRUE cumple una función estratégica dentro del sistema, ya que regula la disponibilidad de camas, coordina el despacho de ambulancias y define el centro asistencial más adecuado según la complejidad del caso.

El objetivo del SEM es:

- Coordinar la atención prehospitalaria.
- Regular el traslado de pacientes según su condición clínica.
- Optimizar el uso de los recursos disponibles.
- Garantizar acceso oportuno y continuo a los servicios de urgencias.

Su funcionamiento se enmarca dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se articula con la Ley 1523 de 2012 en materia de gestión del riesgo, asegurando que la atención de emergencias haga parte de una estructura institucional organizada y no de acciones aisladas.

Para el primer respondiente, comprender la estructura y dinámica del SEM permite reconocer la importancia de una activación oportuna, suministrar información clara al momento de la llamada y facilitar la transición hacia la atención especializada.

3.2. Red pública de urgencias y número único

La red pública de urgencias en Colombia forma parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud y está integrada por instituciones, talento humano y recursos logísticos destinados a garantizar la atención inmediata de personas cuya vida o integridad se encuentren en riesgo. Su finalidad es asegurar continuidad en la atención, desde la recepción del evento hasta la estabilización clínica del paciente.

Esta red comprende:

- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
- Servicios de urgencias hospitalarias.
- Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE).
- Servicios de ambulancia básica y medicalizada.
- Coordinación con bomberos, policía y demás organismos de socorro.

Su funcionamiento se fundamenta en el derecho fundamental a la salud consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política y en la obligación de prestar atención inicial de urgencias sin barreras administrativas cuando exista riesgo vital. Esto significa que ninguna persona puede ser rechazada en una situación crítica por razones económicas o administrativas.

En este contexto, el número único de emergencias 123 constituye el mecanismo de activación inmediata del sistema. Este canal centraliza la recepción de llamadas y permite coordinar la intervención de las entidades competentes según la naturaleza del evento reportado, ya sea de tipo médico, traumático, incendio, alteración del orden público u otra situación crítica.

El uso adecuado del 123 implica:

- Llamar únicamente ante situaciones reales de urgencia o emergencia.
- Proporcionar información clara, precisa y verificable.
- No realizar llamadas falsas o malintencionadas.
- Permanecer en línea para recibir instrucciones del operador.

El número único de emergencias representa el puente entre la actuación inicial del ciudadano o primer respondiente y la respuesta organizada del Estado, permitiendo que la ayuda especializada sea movilizada de manera oportuna y coordinada.

3.3. Activación y técnica de llamada

Una vez identificada la necesidad de apoyo especializado durante la evaluación inicial, el primer respondiente debe activar el Sistema de Emergencias Médicas de manera inmediata. La activación no debe retrasarse por intentos prolongados de intervención cuando exista riesgo vital evidente, como ausencia de respiración, hemorragia abundante o pérdida del estado de conciencia.

La técnica de llamada debe ser organizada, clara y objetiva. Durante la comunicación con el operador del número único de emergencias 123, se recomienda:

- Indicar la ubicación exacta, incluyendo dirección y puntos de referencia visibles.
- Describir brevemente el tipo de evento ocurrido.
- Informar el número aproximado de personas afectadas.
- Señalar el estado general de la víctima (consciente o inconsciente, respira o no respira).
- Advertir sobre riesgos adicionales presentes en el lugar, como incendio, derrames, tránsito vehicular o estructuras inestables.

Para garantizar una comunicación efectiva es importante:

- Mantener la calma y utilizar un tono claro.
- No colgar hasta que el operador lo indique.
- Seguir las instrucciones proporcionadas.
- Delegar la llamada a otra persona si el auxiliador está realizando maniobras de atención.

Una comunicación precisa permite al operador clasificar correctamente la emergencia, asignar los recursos adecuados y orientar acciones inmediatas mientras llega el personal especializado. La activación oportuna del sistema no solo facilita la movilización de ambulancias y organismos de socorro, sino que optimiza los tiempos de respuesta y reduce el riesgo de complicaciones.

La correcta activación del sistema de emergencias marca la transición entre la intervención ciudadana inicial y la respuesta institucional organizada. No obstante, antes de establecer contacto con los servicios especializados, es indispensable reconocer y gestionar adecuadamente los riesgos presentes en el entorno. En consecuencia, el siguiente capítulo aborda la identificación de escenarios de emergencia y la gestión del riesgo como elementos esenciales para una actuación segura y efectiva.

4. Gestión del riesgo

La actuación del primer respondiente no inicia con la intervención directa sobre la víctima, sino con la valoración del entorno en el que ocurre el evento. Antes de cualquier maniobra de atención, es indispensable identificar los riesgos presentes y determinar si el escenario es seguro para intervenir. La gestión del riesgo constituye, por tanto, un componente esencial de la respuesta inicial, ya que permite prevenir nuevos incidentes, proteger la propia integridad y evitar la ampliación del daño.

En Colombia, la gestión del riesgo se encuentra regulada por la Ley 1523 de 2012, que establece la responsabilidad compartida entre el Estado, las entidades territoriales, el sector privado y la comunidad en la prevención, reducción y manejo de desastres. Este enfoque reconoce que la seguridad no depende únicamente de la respuesta institucional, sino también de la capacidad individual y colectiva para anticipar y mitigar peligros.

En el contexto de los primeros auxilios, la gestión del riesgo se traduce en la evaluación sistemática del escenario antes de intervenir. Esto implica observar el entorno, identificar amenazas potenciales, como fuego, tránsito vehicular, estructuras inestables, sustancias peligrosas o violencia activa, y adoptar medidas que reduzcan la exposición a daño. Actuar sin una valoración previa puede convertir al auxiliador en una nueva víctima y agravar la situación.

Este enfoque preventivo se alinea con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, adoptado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en 2015, el cual promueve la comprensión del riesgo como elemento central para la toma de decisiones seguras y responsables.

Comprender la gestión del riesgo permite al primer respondiente diferenciar entre urgencia y emergencia, reconocer factores de riesgo presentes en el entorno y aplicar medidas de minimización antes de establecer contacto con la víctima.

4.1. Urgencia, emergencia y factores de riesgo

Para actuar de manera adecuada en una situación crítica, es fundamental diferenciar entre urgencia y emergencia, ya que esta clasificación orienta la prioridad, la activación del sistema de emergencias y el tipo de intervención inicial.

La urgencia corresponde a una situación que requiere atención médica pronta, pero que no compromete de manera inmediata la vida de la persona. Existe un margen de tiempo razonable para la valoración y traslado asistencial.

Ejemplos de urgencia:

- Heridas leves.
- Esguinces.
- Dolor moderado sin alteración de signos vitales.

La emergencia, en cambio, implica un riesgo vital inminente. La ausencia de intervención inmediata puede generar secuelas graves o la muerte, por lo que exige actuación prioritaria y activación inmediata del Sistema de Emergencias Médicas.

Ejemplos de emergencia:

- Paro cardiorrespiratorio.
- Hemorragia abundante.
- Pérdida de conciencia.

- Trauma grave.

En la práctica, el criterio diferenciador radica en la presencia o no de compromiso de funciones vitales como respiración, circulación o estado de conciencia.

Por otra parte, un factor de riesgo es cualquier condición, agente o circunstancia que incrementa la probabilidad de daño. Estos pueden clasificarse en:

- Físicos, como tránsito vehicular o estructuras inestables.
- Biológicos, como contacto con sangre o fluidos corporales.
- Químicos, como derrames o gases tóxicos.
- Eléctricos, como cables expuestos.
- Ambientales, como fuego o inundaciones.
- Mecánicos, como maquinaria en funcionamiento.

La identificación temprana de estos factores permite aplicar el principio fundamental de autoprotección. El primer respondiente debe garantizar su seguridad antes de intervenir, evitando convertirse en una nueva víctima y preservando la continuidad de la atención.

4.2. Identificación de riesgos y tipos de accidentes

Los eventos que requieren primeros auxilios pueden presentarse en diversos contextos, cada uno con características particulares que condicionan el tipo de lesión y la forma de intervención. La identificación del entorno permite anticipar mecanismos de lesión, priorizar la atención y aplicar medidas preventivas adecuadas.

En el hogar, los riesgos más frecuentes incluyen caídas, quemaduras, intoxicaciones y cortaduras. En el ámbito laboral pueden asociarse a maquinaria, alturas, sustancias químicas o electricidad. En espacios públicos se presentan accidentes de tránsito, aglomeraciones o situaciones derivadas de fenómenos naturales.

Los accidentes son eventos no intencionales que generan lesiones físicas o alteraciones en la salud, y constituyen una de las principales causas de morbilidad en diferentes grupos poblacionales. Reconocer su tipología permite al primer respondiente adaptar su actuación con mayor precisión.

Tabla 4. Tipos de accidentes más frecuentes

Tipo de accidente	Contexto habitual	Lesiones frecuentes	Consideración para el primer respondiente
Domésticos.	Hogares.	Caídas, quemaduras, intoxicaciones, cortaduras y asfixia.	Verificar condiciones de seguridad y presencia de menores o adultos mayores.
Escolares o en hogares infantiles.	Instituciones educativas.	Golpes, atragantamientos,	Movilizar con precaución y

Tipo de accidente	Contexto habitual	Lesiones frecuentes	Consideración para el primer respondiente
		caídas y lesiones deportivas.	evaluar estado neurológico.
Laborales.	Entornos productivos.	Atrapamientos, caídas de altura, descargas eléctricas y exposición química.	Identificar riesgos activos y cumplir protocolos de seguridad.
Vehiculares.	Vías públicas.	Politraumatismos, fracturas, lesiones cervicales y hemorragias.	Asegurar la escena antes de intervenir.
Deportivos.	Escenarios recreativos.	Esguinces, luxaciones, fracturas y deshidratación.	Evaluar mecanismo de lesión y signos vitales.
Derivados de eventos naturales.	Zonas afectadas por desastres.	Lesiones múltiples, aplastamientos y	Priorizar autoprotección y

Tipo de accidente	Contexto habitual	Lesiones frecuentes	Consideración para el primer respondiente
		trauma generalizado.	coordinación institucional.

En Colombia, la prevención y control de riesgos laborales se enmarca en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mientras que los eventos derivados de fenómenos naturales se regulan conforme a la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo de desastres.

La identificación de riesgos constituye el primer paso para una intervención segura. Sin embargo, reconocer el peligro no es suficiente si no se adoptan acciones concretas orientadas a reducirlo. Una vez detectados los factores que pueden agravar la situación, el primer respondiente debe aplicar medidas básicas de minimización que permitan controlar el entorno y disminuir la probabilidad de nuevos incidentes.

4.3. Medidas de minimización y precaución

Una vez identificados los factores de riesgo presentes en el entorno, el primer respondiente debe adoptar acciones básicas orientadas a disminuir la probabilidad de que el evento se agrave o genere nuevas víctimas. Estas medidas hacen parte del enfoque de reducción del riesgo y constituyen una fase previa al aseguramiento formal del escenario.

La minimización del riesgo no implica controlar completamente la situación, sino aplicar decisiones prudentes que permitan intervenir sin exponerse innecesariamente. La seguridad personal es la primera prioridad en cualquier actuación en primeros auxilios.

Antes de acercarse a la víctima, se debe realizar una verificación rápida del entorno que incluya:

- Estabilidad del escenario inmediato.
- Presencia de tránsito vehicular activo.
- Existencia de cables eléctricos, fuego o sustancias peligrosas.
- Posibilidad de derrumbes o estructuras inestables.
- Riesgo de violencia activa o presencia de agresores.

Si el riesgo es alto o no puede ser controlado con medidas básicas, la prioridad es activar el Sistema de Emergencias Médicas y esperar apoyo especializado. Ninguna intervención justifica poner en peligro la vida del auxiliador.

Tabla 5. Medidas según tipo de riesgo

Tipo de riesgo	Medidas de precaución recomendadas
Físico o estructural.	Mantener distancia prudente, no ingresar a zonas inestables, evitar manipular estructuras dañadas.
Eléctrico.	No tocar cables expuestos, cortar la fuente de energía si es posible y seguro, evitar superficies húmedas en contacto con electricidad.

Tipo de riesgo	Medidas de precaución recomendadas
Químico.	No inhalar vapores, no tocar sustancias desconocidas, evitar contacto directo con líquidos derramados.
Biológico.	Usar guantes si hay contacto con fluidos, evitar exposición directa a sangre, realizar higiene posterior a la intervención.
Ambiental.	Protegerse de lluvia intensa, humo o calor extremo, reubicar a la víctima si el entorno lo permite y es seguro.

Cuando hay múltiples personas en el lugar, el control del entorno es fundamental para evitar desorden y nuevos riesgos. Se recomienda:

- Evitar aglomeraciones alrededor de la víctima.
- Solicitar espacio suficiente para la atención.
- Delegar tareas simples como llamar al 123 o traer un botiquín.
- Mantener comunicación clara y calmada para reducir el pánico colectivo.

Estas acciones disminuyen el caos inicial, mejoran la coordinación y facilitan la posterior intervención institucional.

La regla fundamental es no convertirse en una nueva víctima. La atención solo debe iniciarse cuando el entorno sea razonablemente seguro o cuando el riesgo haya sido parcialmente controlado. La seguridad del primer respondiente garantiza la continuidad de la ayuda y fortalece la efectividad del sistema de emergencias.

5. Aseguramiento y control del escenario

El aseguramiento del escenario constituye una responsabilidad esencial del primer respondiente en situaciones de urgencia y emergencia. Su finalidad es garantizar que la intervención se realice en condiciones mínimas de seguridad, orden y control, evitando la generación de nuevos riesgos para la víctima, el auxiliador o terceros.

Asegurar el escenario no se limita al acordonamiento físico del área. Implica adoptar una actitud preventiva, evaluar el contexto de manera crítica y mantener dominio situacional mientras se activa la respuesta especializada. Esta actuación se articula con la fase “Proteger” del principio PAS (Proteger, Alertar, Socorrer), el cual orienta la secuencia básica de actuación en primeros auxilios.

Desde el punto de vista jurídico, el aseguramiento del escenario se relaciona con el deber de actuar con prudencia y debida diligencia, evitando conductas temerarias o intervenciones que puedan agravar el daño. La protección de la vida constituye la prioridad absoluta; el control razonable del entorno es el medio para garantizar esa protección.

El aseguramiento es una acción previa y transversal a todas las demás fases de la atención inicial. Sin condiciones mínimas de seguridad, no debe iniciarse intervención directa sobre la víctima. En caso de riesgo incontrolable, la actuación correcta consiste en mantener distancia segura, activar el Sistema de Emergencias Médicas y facilitar el acceso de los organismos especializados.

En este sentido, el control del escenario cumple tres propósitos fundamentales:

- Proteger al primer respondiente.
- Evitar la ampliación del daño o la aparición de nuevas víctimas.

- Facilitar la intervención coordinada de los servicios especializados.

El dominio del entorno no requiere autoridad formal, sino liderazgo básico, comunicación clara y toma de decisiones prudente. La capacidad de organizar el espacio y mantener la calma influye directamente en la eficacia de la respuesta inicial.

5.1. Principios y criterios de aseguramiento

El aseguramiento del escenario se rige por principios técnicos que orientan la actuación prudente del primer respondiente. Este proceso tiene límites claros y debe realizarse dentro del nivel de formación, competencia y capacidad real de control del auxiliador.

El primer principio es la autoprotección. Ninguna intervención debe iniciarse si existe un riesgo grave e inminente para quien presta ayuda. Convertirse en una nueva víctima no solo agrava la situación, sino que dificulta la respuesta institucional.

El segundo principio es la evaluación continua del entorno. El escenario de emergencia es dinámico; por ello, el riesgo debe reevaluarse de manera permanente. Condiciones como tránsito vehicular, fuego, presencia de sustancias peligrosas o alteraciones del orden público pueden cambiar rápidamente.

El tercer principio es la proporcionalidad de la actuación. El primer respondiente no está obligado a controlar completamente el escenario, sino a adoptar medidas razonables que reduzcan el peligro inmediato mientras llega el apoyo especializado.

En términos operativos, el aseguramiento implica:

- Reconocer riesgos activos o potenciales.
- Evitar la exposición innecesaria al peligro.
- Limitar el acceso de personas no involucradas.
- Solicitar apoyo especializado cuando el riesgo supera la capacidad de control.
- Mantener orden básico y comunicación clara en el entorno.

Asimismo, el criterio de debida diligencia exige actuar con prudencia, sin omitir ayuda cuando sea posible prestarla, pero sin exceder las propias capacidades técnicas.

El aseguramiento no es una acción puntual, sino un proceso que se mantiene durante toda la intervención. La observación constante del entorno y la capacidad de adaptación permiten garantizar que la atención se realice en condiciones razonablemente seguras hasta la llegada de los servicios especializados.

5.2. Acordonamiento y control del evento

El acordonamiento constituye una medida básica de control del escenario que busca delimitar físicamente el área donde ocurrió el evento, con el fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad y orden. No se trata únicamente de aislar el espacio, sino de organizar el entorno para facilitar la atención y evitar nuevos riesgos.

El acordonamiento tiene como objetivos principales:

- Evitar el ingreso de curiosos o personas no autorizadas.
- Reducir interferencias durante la atención.

- Proteger la integridad de la víctima.
- Disminuir el riesgo de nuevos incidentes.
- Preservar posibles evidencias cuando la situación lo requiera.

En escenarios urbanos o comunitarios, el control del área puede realizarse mediante:

- Señalización visible con elementos disponibles.
- Uso de conos, cintas, vehículos o barreras físicas.
- Ubicación estratégica de personas que orienten el tránsito o el flujo peatonal.
- Comunicación clara y firme para mantener distancia de seguridad.

En accidentes de tránsito, el control del evento adquiere especial relevancia. Se recomienda:

- Señalizar a una distancia prudente del punto del impacto.
- Activar luces intermitentes si se dispone de vehículo.
- Evitar mover vehículos involucrados salvo que exista riesgo inmediato, como incendio o colisión secundaria.
- Controlar el flujo vehicular solo si las condiciones lo permiten y sin exponerse a peligro.

El acordonamiento debe ser proporcional al tipo de evento y mantenerse mientras persista el riesgo. Si el escenario presenta condiciones de alto peligro, como incendio activo, derrame químico significativo o colapso estructural, la prioridad es

activar de inmediato a los organismos especializados y abstenerse de intervenir directamente.

El control adecuado del evento permite una transición organizada hacia la intervención institucional y garantiza que la atención inicial se desarrolle en un entorno razonablemente seguro.

6. Clasificación y custodia

En situaciones con una o múltiples personas lesionadas, el primer respondiente debe aplicar criterios básicos de priorización que permitan organizar la atención de manera racional, objetiva y segura. La clasificación de víctimas optimiza el uso de recursos disponibles, facilita la toma de decisiones bajo presión y puede ser determinante para preservar la vida en escenarios con múltiples afectados. Esta priorización no implica seleccionar quién recibe ayuda y quién no, sino establecer un orden de atención basado en la gravedad y la probabilidad de supervivencia.

Asimismo, en eventos asociados a accidentes de tránsito, hechos violentos o situaciones con posibles implicaciones legales, la actuación debe desarrollarse con especial cuidado respecto al entorno. La preservación del escenario evita alteraciones innecesarias que puedan afectar investigaciones posteriores o procesos judiciales. En este contexto adquiere relevancia el concepto de cadena de custodia, entendido como el conjunto de procedimientos orientados a garantizar la integridad de posibles elementos materiales de prueba.

La intervención del primer respondiente, por tanto, debe equilibrar dos dimensiones complementarias: la priorización técnica de la atención y la preservación responsable del escenario cuando existan implicaciones legales.

6.1. Triage y aplicación básica

El triage es el procedimiento de clasificación rápida y sistemática de las víctimas en una situación de urgencia o emergencia, cuyo propósito es establecer prioridades de

atención según la gravedad clínica y el riesgo vital, especialmente cuando los recursos disponibles son limitados.

Su finalidad no es emitir diagnósticos, sino organizar la atención para salvar el mayor número de vidas posible, priorizando a quienes presentan mayor riesgo inmediato.

En el ámbito prehospitalario y en eventos con múltiples víctimas, el triage permite:

- Identificar personas con riesgo vital inminente.
- Determinar prioridades cuando los recursos son insuficientes.
- Evitar que lesiones leves consuman tiempo crítico.
- Organizar el flujo de atención hasta la llegada de apoyo especializado.
- Reducir el caos operativo en escenarios de alta tensión.

Es especialmente relevante en accidentes de tránsito con múltiples lesionados, incendios, eventos masivos, desastres naturales y emergencias laborales con varios afectados.

En Colombia, el triage hospitalario se encuentra regulado por lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. En el ámbito prehospitalario, el primer respondiente realiza una priorización preliminar basada en criterios observables.

Tabla 6. Clasificación básica por niveles de prioridad

Nivel	Color	Prioridad	Características orientadoras
triage I.	Rojo.	Atención inmediata.	Riesgo vital inminente. No respira o presenta dificultad severa, hemorragia masiva, inconsciente, trauma grave y signos de shock.
triage II.	Naranja.	Muy urgente.	Alto riesgo de deterioro rápido. Dolor torácico intenso, dificultad respiratoria moderada y alteración del estado mental.
triage III.	Amarillo.	Urgente.	Condición estable sin riesgo vital inmediato.

Nivel	Color	Prioridad	Características orientadoras
			Fracturas sin shock, heridas moderadas y dolor significativo.
triage IV.	Verde.	No urgente.	Lesiones leves. Puede caminar y no presenta compromiso general.
triage V.	Azul.	Consulta no prioritaria.	Condiciones médicas sin urgencia vital. Más frecuente en ámbito hospitalario.

A continuación, se presenta un esquema de clasificación de triage adoptado en Colombia, que organiza a los pacientes en cinco niveles codificados por colores, de acuerdo con la gravedad clínica y la prioridad de atención, desde riesgo vital inminente hasta consulta no prioritaria.

Clasificación básica para niveles de prioridad:

- **Triage I**

Requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico, pérdida de miembro u órgano u otras condiciones que por norma exijan atención inmediata.

- **Triage II**

La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto, requiere una atención que no debe superar los treinta (30) minutos.

- **Triage III**

La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico aunque su situación puede empeorar si no se actúa.

- **Triage IV**

El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. No obstante, existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente.

- **Triage V**

El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general de paciente y no representa un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de miembro u órgano.

Nota. Tomado del Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.).

En este contexto, el primer respondiente puede orientarse mediante criterios observables y preguntas simples que facilitan una clasificación rápida:

- ¿La víctima respira?
- ¿Está consciente?
- ¿Presenta sangrado abundante?
- ¿Puede caminar?
- ¿Presenta signos de confusión o desorientación?

En eventos con múltiples víctimas, una estrategia operativa básica consiste en solicitar que quienes puedan caminar se trasladen a un punto previamente definido. Esta acción permite identificar rápidamente posibles casos de menor gravedad y organizar de manera preliminar el escenario.

El triage se fundamenta en principios de justicia distributiva, beneficencia y maximización de la supervivencia colectiva. Priorizar no significa valorar más una vida que otra, sino aplicar un criterio técnico orientado a preservar el mayor número de personas posible bajo condiciones de recursos limitados.

El triage inicial constituye una herramienta de organización y no una evaluación médica definitiva. Su correcta aplicación facilita la transición entre la respuesta inicial del primer respondiente y la atención especializada dentro del Sistema de Emergencias Médicas.

6.2. Cadena de custodia

La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos destinados a garantizar la conservación, integridad, autenticidad y trazabilidad de los elementos materiales probatorios que puedan tener relevancia en un proceso judicial. Su finalidad es evitar la alteración, pérdida, contaminación o manipulación indebida de evidencias.

Aunque el primer respondiente no cumple funciones investigativas ni judiciales, su intervención en el escenario puede influir directamente en la preservación de posibles elementos probatorios. Por ello, debe conocer y aplicar principios básicos de protección del lugar de los hechos, especialmente en eventos como accidentes de tránsito con lesiones graves o fallecidos, situaciones asociadas a violencia física, sospecha de delito, muerte aparente, accidentes laborales con posible responsabilidad jurídica o incidentes con armas o sustancias peligrosas.

En este contexto, es importante aplicar principios básicos de actuación, en donde el primer respondiente orienta su conducta bajo tres criterios fundamentales: la prioridad de la vida sobre la evidencia, la intervención mínima necesaria y la preservación proporcional del entorno. La atención vital siempre prevalece sobre la conservación del escenario.

En cuanto a las conductas recomendadas, cuando las condiciones lo permitan y sin poner en riesgo su seguridad ni la atención de la víctima, el primer respondiente debe:

- Evitar mover objetos innecesariamente.
- No retirar elementos incrustados en la víctima.
- No manipular armas u objetos sospechosos.
- Limitar el acceso de curiosos o terceros.
- Delimitar o acordonar el área si es posible.
- Evitar pisar o alterar zonas críticas.
- Informar oportunamente a la autoridad competente sobre la situación.

De igual manera, existen conductas que deben evitarse, tales como:

- Realizar recolección de evidencias.
- Guardar objetos por iniciativa propia.
- Limpiar la escena.
- Modificar la posición de elementos sin necesidad.
- Emitir juicios sobre responsabilidades.
- Tomar fotografías para difusión personal.

Finalmente, la actuación debe acompañarse de una observación prudente.

Siempre que no interfiera con la atención vital, el primer respondiente puede:

- Recordar la ubicación original de la víctima.
- Observar la posición de objetos relevantes.
- Identificar el número aproximado de personas presentes.
- Informar verbalmente a la autoridad sobre lo observado.

No se exige documentación formal al primer respondiente comunitario; sin embargo, se espera una actuación consciente, ética y proporcional a sus competencias. Su función no es investigar, sino proteger la vida y facilitar la intervención de las autoridades competentes cuando sea necesario.

7. Bioseguridad y preparación

La bioseguridad en primeros auxilios constituye un pilar fundamental para garantizar la protección del primer respondiente y de la víctima durante la atención inicial. Toda intervención en un escenario de emergencia puede implicar exposición a fluidos corporales, agentes biológicos, riesgos ambientales, superficies contaminadas o materiales potencialmente infecciosos. Por esta razón, la aplicación de medidas preventivas es obligatoria antes, durante y después de la asistencia.

Las precauciones universales parten del principio de considerar que toda persona puede ser portadora de agentes infecciosos, independientemente de su diagnóstico conocido. En este sentido, la aplicación sistemática de medidas de higiene, control y barrera reduce significativamente el riesgo de transmisión de enfermedades. Estas orientaciones se encuentran respaldadas por las recomendaciones técnicas emitidas por la Organización Mundial de la Salud (2009), que establecen lineamientos sobre higiene de manos, uso de elementos de protección personal y manejo seguro de fluidos biológicos.

En el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo en Colombia, la prevención del riesgo biológico forma parte de los deberes básicos de protección individual y colectiva. La intervención responsable exige no solo el uso adecuado de elementos de protección personal, sino también la preparación previa del botiquín de primeros auxilios, la verificación de insumos y el conocimiento de protocolos básicos de actuación segura.

La bioseguridad no es una acción aislada, sino una conducta permanente que acompaña cada etapa de la atención prehospitalaria. Su correcta aplicación protege al

primer respondiente, evita la contaminación cruzada y contribuye a una atención segura, ética y profesional.

7.1. Principios y técnica aséptica

La bioseguridad se fundamenta en el principio de precaución universal, según el cual todo fluido corporal, como sangre, saliva, vómito o secreciones respiratorias, debe considerarse potencialmente contaminante, independientemente de la existencia de un diagnóstico confirmado. Este enfoque reduce el riesgo de transmisión de agentes biológicos, tales como virus, bacterias y hongos.

En consecuencia, el primer respondiente debe asumir medidas de protección sistemáticas en toda intervención, aun cuando el riesgo no sea evidente.

Entre los principios básicos de actuación se encuentran:

- Evitar el contacto directo con sangre u otros fluidos corporales.
- Utilizar elementos de protección personal cuando estén disponibles, como guantes, tapabocas o barreras físicas improvisadas.
- Realizar higiene de manos antes y después de la atención, preferiblemente con agua y jabón o soluciones alcohólicas cuando no sea posible el lavado convencional.
- Desechar materiales contaminados de manera segura, evitando su reutilización.
- Evitar tocarse el rostro, ojos, nariz o boca durante la intervención.
- Cubrir heridas o lesiones propias antes de prestar ayuda.

La higiene de manos constituye la medida más eficaz para prevenir la transmisión de infecciones. Incluso cuando se utilizan guantes, estos no sustituyen la necesidad de lavado o desinfección posterior.

La técnica aséptica corresponde al conjunto de procedimientos orientados a prevenir la contaminación y limitar la propagación de microorganismos durante la atención. En el contexto de primeros auxilios comunitarios, no implica esterilidad hospitalaria, sino la aplicación consciente de medidas básicas de limpieza y protección.

Título del podcast: **Técnica aséptica básica**

Hombre: En algún momento todos hemos sufrido una herida. Un pequeño corte en la cocina, una “raspada” durante una caída o una lesión realizando algún tipo de ejercicio.

Son situaciones cotidianas que muchas veces no parecen importantes pero que requieren cuidado desde el momento en que pasan.

Mujer: Porque una herida abierta no solo afecta la piel.

También puede convertirse en la puerta de entrada para microorganismos que provocan infecciones.

Por eso, además de controlar el sangrado o cubrir la lesión, es importante mantener la herida lo más limpia posible.

Hombre: De ahí la importancia de la técnica aséptica básica, porque cualquier fluido corporal puede estar contaminado.

Mujer: Actuar con precaución ayuda a proteger tanto a la persona lesionada como a quien la está ayudando. (Pausa corta)

Uno de los primeros pasos es limpiar la herida utilizando agua potable o solución salina para retirar cualquier residuo visible.

Hombre: Después de que se limpia, la herida debe cubrirse con material estéril disponible en el botiquín, como gasas o apósitos, para ayudar a proteger el área lesionada mientras la persona recibe atención médica.

Mujer: Es importante evitar soplar la herida, tocarla directamente o manipularla porque esto puede aumentar el riesgo de infección.

Hombre: Cubrir la herida con una gasa o un apósito ayuda a mantenerla protegida. (Pausa corta)

Y si se atiende a más de una víctima, es importante usar guantes nuevos para cada persona o lavarse las manos antes de continuar.

Mujer: Estas medidas ayudan a prevenir la contaminación cruzada y protegen tanto a las víctimas como a quien presta la ayuda.

Hombre: Los procedimientos más complejos los realiza el personal de salud.

Pero quien presta la primera ayuda también puede influir mucho aplicando estas medidas básicas de higiene.

Mujer: Recuerden que en primeros auxilios muchas complicaciones se pueden evitar con cuidados sencillos desde la primera atención.

La técnica aséptica básica protege al paciente y a quien presta la ayuda.

Hombre: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo programa.

Es importante comprender que la técnica aséptica avanzada corresponde al personal sanitario en entornos clínicos. Sin embargo, el primer respondiente cumple un papel preventivo fundamental al aplicar principios básicos de higiene, barrera y control de contaminación.

La bioseguridad no solo protege al auxiliador, sino que también evita la transmisión cruzada entre víctimas y contribuye a una atención más segura y responsable dentro del Sistema de Emergencias Médicas.

7.2. Métodos de barrera

Los métodos de barrera constituyen una herramienta esencial para minimizar la exposición a riesgos biológicos durante la atención inicial. Su finalidad es interponer un elemento físico entre el primer respondiente y los fluidos corporales o secreciones potencialmente contaminantes, reduciendo así la probabilidad de transmisión de enfermedades.

Entre los más utilizados se encuentran:

- Guantes desechables, preferiblemente de látex o nitrilo, para evitar el contacto directo con sangre, secreciones o tejidos lesionados.
- Protector nasobucal o mascarilla quirúrgica, especialmente cuando exista riesgo de exposición a secreciones respiratorias.
- Mascarillas o dispositivos con válvula unidireccional para reanimación cardiopulmonar, que permiten realizar ventilaciones de rescate de manera más segura.
- Gafas o protectores oculares cuando exista riesgo de salpicaduras.

El uso de estos elementos debe realizarse antes del contacto con la víctima siempre que la situación lo permita. Asimismo, deben retirarse cuidadosamente para evitar la contaminación cruzada, evitando tocar la parte externa del elemento utilizado y realizando higiene de manos inmediatamente después de su retiro.

Cuando no se disponga de elementos de barrera, el primer respondiente debe evaluar el riesgo y, de ser necesario, priorizar maniobras que no impliquen contacto directo con fluidos, activando oportunamente el Sistema de Emergencias Médicas.

7.3. Botiquín de primeros auxilios y preparación de insumos

El botiquín de primeros auxilios es el conjunto organizado de insumos básicos destinados a brindar atención inicial en caso de accidente o emergencia. Su finalidad es facilitar una respuesta rápida, ordenada y segura mientras se activa el Sistema de Emergencias Médicas.

En Colombia, los entornos laborales deben contar con botiquines conforme a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo contenido varía según el nivel de riesgo de la actividad económica y el número de trabajadores expuestos.

Un botiquín básico puede contener:

- Guantes desechables.
- Gasas estériles.
- Vendas elásticas y vendas triangulares.
- Apósitos adhesivos de diferentes tamaños.
- Solución antiséptica.
- Suero fisiológico para irrigación.
- Tijeras de punta roma.
- Mascarilla o dispositivo para reanimación cardiopulmonar.
- Elementos para control básico de hemorragias.

Es importante que el botiquín:

- Esté ubicado en un lugar visible, accesible y señalizado.
- Permanezca protegido del calor, humedad o contaminación.
- Sea revisado periódicamente para verificar fechas de vencimiento.
- Mantenga inventario actualizado.
- No contenga medicamentos sin control o prescripción profesional.

La presencia de medicamentos puede implicar responsabilidad legal si se administran sin autorización o sin competencia profesional, especialmente en entornos laborales o comunitarios.

La preparación adecuada implica verificar previamente la disponibilidad y el estado de los elementos necesarios antes de que ocurra una emergencia. No se trata únicamente de tener un botiquín, sino de garantizar que esté operativo y organizado.

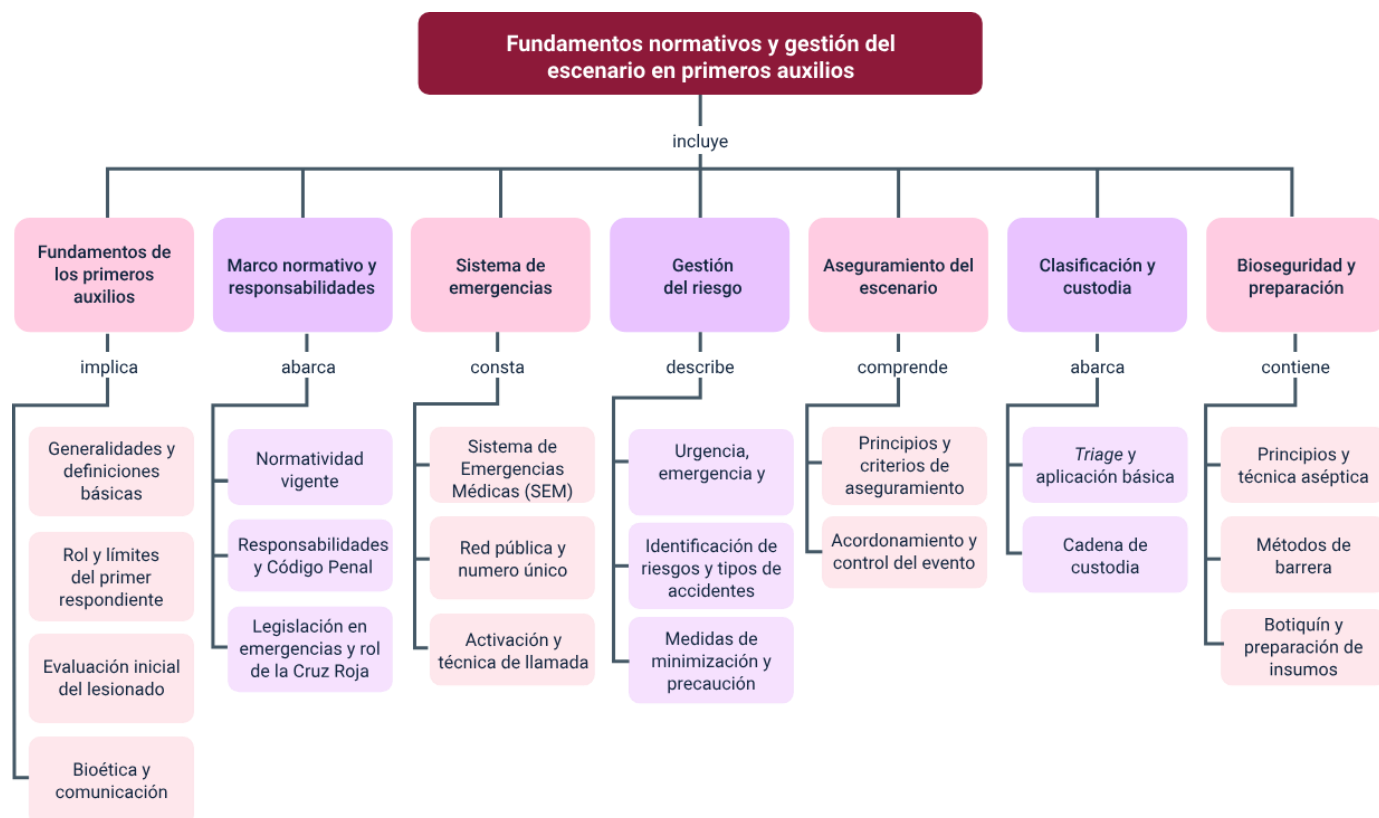
Antes de intervenir, el primer respondiente debe:

- Confirmar que cuenta con elementos de protección personal.
- Revisar rápidamente el contenido básico del botiquín.
- Verificar que el material esté en condiciones adecuadas.
- Organizar los insumos que va a utilizar para evitar improvisaciones.

La improvisación aumenta el riesgo de errores, retrasa la atención y puede generar exposición innecesaria a riesgos biológicos o mecánicos. Una preparación anticipada mejora la eficacia de la respuesta y fortalece la seguridad del primer respondiente.

Síntesis

El componente formativo aborda los fundamentos normativos, éticos y operativos que orientan la actuación del primer respondiente en situaciones de urgencia y emergencia. Integra los principios básicos de los primeros auxilios, el marco legal colombiano, el funcionamiento del Sistema de Emergencias Médicas, la gestión del riesgo, el aseguramiento del escenario, la priorización de víctimas mediante criterios básicos de triage y la preservación elemental de evidencias cuando sea necesario. Asimismo, desarrolla lineamientos de bioseguridad, métodos de barrera y preparación adecuada del botiquín, con el propósito de garantizar intervenciones seguras, responsables y técnicamente fundamentadas que protejan la vida y la integridad de las personas sin generar nuevos riesgos.



Glosario

Acordonamiento: delimitación física del área donde ocurrió un evento adverso, con el fin de proteger a la víctima, evitar interferencias externas y reducir riesgos adicionales durante la atención inicial.

Auxiliador: persona que brinda asistencia inmediata aplicando conocimientos básicos de primeros auxilios, respetando los límites de su formación y actuando conforme a protocolos establecidos.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas destinadas a minimizar el riesgo de exposición a agentes biológicos durante la atención de una emergencia, protegiendo tanto a la víctima como al primer respondiente.

Botiquín de primeros auxilios: conjunto organizado de insumos básicos destinados a brindar atención inicial en caso de accidente o emergencia, conforme a lineamientos de seguridad y normatividad aplicable.

Cadena de custodia: procedimiento que garantiza la preservación, integridad y trazabilidad de elementos materiales probatorios en un escenario donde puedan existir implicaciones legales.

Comunicación asertiva en emergencia: forma clara, precisa y organizada de transmitir información durante una situación de urgencia, facilitando la coordinación con el Sistema de Emergencias Médicas.

Emergencia: situación crítica que pone en peligro inmediato la vida o la integridad de una persona y requiere intervención urgente para evitar consecuencias graves.

Evaluación inicial del lesionado: proceso sistemático y rápido de valoración primaria orientado a identificar condiciones que comprometan la vida y definir la activación del sistema de emergencias.

Factor de riesgo: condición o circunstancia que incrementa la probabilidad de que ocurra un accidente o que agrave sus consecuencias.

Gestión del riesgo: proceso orientado a identificar, analizar y reducir los riesgos asociados a una situación de emergencia, priorizando la seguridad del entorno.

Métodos de barrera: elementos de protección personal utilizados para prevenir el contacto directo con fluidos corporales, tales como guantes, mascarillas y gafas de protección.

Primer respondiente: persona que interviene inicialmente en el lugar donde ocurre un evento adverso, brindando asistencia básica mientras se activa el sistema formal de atención en salud.

Principio PAS: protocolo básico de actuación en primeros auxilios que establece el orden lógico de intervención: Proteger, Avisar y Socorrer.

Red pública de urgencias: conjunto de instituciones, recursos y servicios articulados dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud para atender eventos que requieren intervención inmediata.

Sistema de Emergencias Médicas (SEM): modelo organizativo encargado de coordinar la respuesta prehospitalaria, el traslado y la atención inicial en situaciones de urgencia y emergencia.

Triage: proceso de clasificación de víctimas en función de la gravedad de sus lesiones y la prioridad de atención.

Urgencia: situación que requiere atención médica pronta, pero que no implica necesariamente riesgo vital inmediato.

Víctima: persona que sufre una lesión, enfermedad súbita o evento traumático que compromete su estado de salud físico o mental.

Referencias bibliográficas

American Heart Association. (s. f.). American Heart Association.

<https://www.heart.org/>

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics (8th ed.). Oxford University Press.

Congreso de la República de Colombia. (2000). Ley 599 de 2000: Por la cual se expide el Código Penal.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388>

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1523 de 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141>

Consejo Colombiano de Seguridad. (2024). Primeros auxilios en accidentes de tránsito, ¿cómo actuar correctamente?

https://ccs.org.co/portfolio/primeros_auxilios_accidentes_transito/

Constitución Política de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia.

<http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica>

Cruz Roja Colombiana. (s.f.). Manual básico de primeros auxilios.

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). Aseguramiento al sistema general de salud.

<https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsubsidado/Paginas/aseguramiento-al-sistema-general-salud.aspx>

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). Triage.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/triage.aspx>

Ministerio de Salud y Protección Social. (s.f.). Sistema de Emergencias Médicas (SEM). <https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-de-emergencias-medicas-SEM.aspx>

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030.

<https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>

Organización Mundial de la Salud. (2009). WHO guidelines on hand hygiene in health care.

<https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/b7cdc469-d662-4958-adfd-949a750e5ad9/content>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Dirección General
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Laura Brigitte Perea Possos	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Ivan Uribe Ortiz	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jose Yobani Penagos Mora	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Sebastian Trujillo Afanador	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima